

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	妊娠高血壓疾病 Hypertensive disorders of pregnancy				
編號	A31000-Q03-W-M12	制定者	R9 黃麗華	公布日期	102 年 04 月 26 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.8 版/9 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員能了解並正確執行妊娠高血壓個案照護。

二、範圍

婦產科單位。

三、說明

(一) 定義

妊娠高血壓疾病包含妊娠高血壓、子癇前症、重度子癇症、子癇症、慢性高血壓伴隨子癇前症。

1. 妊娠高血壓：妊娠 20 週以後至少兩次間隔 4 小時的兩次收縮壓 $\geq 140\text{mmHg}$ 、舒張壓 $\geq 90\text{mmHg}$ ，並不伴隨子癇前症或高血壓性血管疾病的症狀，在生產後的 10 天內消失。
2. 子癇前症/重度子癇前症-妊娠 20 週以後至少兩次間隔 4 小時的兩次收縮壓 $\geq 140\text{mmHg}$ 、舒張壓 $\geq 90\text{mmHg}$ ，伴隨有以下其中一種症狀：蛋白尿或血小板減少，腎功能不全，肝功能受損，肺水腫或新發頭痛；如收縮壓 $\geq 160\text{mmHg}$ 、舒張壓 $\geq 110\text{mmHg}$ ，則為重度子癇前症。
3. 慢性高血壓伴隨子癇前症：妊娠 20 週前即有高血壓情形，於 20 週後出現子癇前症的症狀。

主題名稱	妊娠高血壓疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M12	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	2/9

(二) 症狀

分類	血壓變化	蛋白尿	水腫	其他症狀
妊娠高血壓	收縮壓 $\geq 140\text{mmHg}$ 舒張壓 $\geq 90\text{mmHg}$	-	-	-
子癇前症	收縮壓 $\geq 140\text{mmHg}$ 舒張壓 $\geq 90\text{mmHg}$	收集 24 小時小便尿蛋白在 300mg 以上或隨意抽樣尿蛋白為(+)或(++)。	大都發生在下肢內側，眼睛、臉、手指也有輕微腫脹，但無肺囉音。	A. 血小板減少(少於 $100,000 \times 10^9/\text{L}$)。 B. 腎功能不全。 C. 肝功能受損。 D. 肺水腫。 E. 新發頭痛。
重度子癇前症	收縮壓 $\geq 160\text{mmHg}$ 舒張壓 $\geq 110\text{mmHg}$	收集 24 小時小便，蛋白在 300mg 以上或隨意抽樣尿蛋白為(+++)或(++++)。	手、腳、臉、下腹部，明顯水腫，且有肺水腫並出現囉音。	A. 血小板減少(少於 $100,000 \times 10^9/\text{L}$)。 B. 腎功能不全。 C. 肝功能受損。 D. 肺水腫。 E. 新發頭痛。 F. HELLP 症候群。
子癇症	具有子癇前症之症狀並合併有痙攣、昏迷之現象。		前驅症狀： A. 頭痛-因腦水腫引起。 B. 視覺障礙。 C. 上腹部疼痛。 D. 意識欠清：如興奮過度、哭鬧不安等。	
慢性子癇前症合併高血壓	懷孕前即有高血壓，合併發生子癇前症或子癇症。	與子癇前症相同。	與子癇前症相同。	

(三) 常見治療

- 理想血壓宜控制在 140~150/90~100mmHg，如出現持續性 (≥ 15 分鐘) 的急性嚴重高血壓 (收縮壓 $\geq 160\text{mmHg}$ 或舒張壓 $\geq 110\text{mmHg}$) 應迅速採取降壓治療。

- 常用之降血壓藥物是：

(1) Apresoline

(2) Adalat

主題名稱	妊娠高血壓疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M12	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	3/9

(3)Trandate

(4)MgSO₄

(四) 護理問題

1. 尋求（特定的）健康協助／對疾病不了解有關。
2. 焦慮感受／擔心早產。
3. 易感染／早期破水。
4. 缺乏營養／血色素低。
5. 疼痛不適／與疾病引起子宮收縮有關。
6. 自我照顧尋求協助：如廁／依醫囑須絕對臥床休息。
7. 心肺血流不足／高血容積。

(五) 護理措施

1. 尋求（特定的）健康協助／對疾病不了解有關評估個案及家屬的認知。
 - (1) 衛教高血壓藥物的作用及副作用，若感覺視力模糊、頭痛不適須立即告知護理人員。
 - (2) 鼓勵若有任何有關妊娠誘發性高血壓之問題可隨時提出。
 - (3) 教導妊娠誘發性高血壓之注意事項。
 - (4) 給予妊娠誘發性高血壓衛教單張。
 - (5) 教導妊娠誘發性高血壓對胎兒及胎盤之影響。
2. 焦慮感受／擔心早產
 - (1) 評估個案焦慮程度及主要原因。
 - (2) 請醫師解釋疾病目前狀況與對胎兒的影響。
 - (3) 胎兒監視器監測時，隨時注意子宮收縮頻率與強度及胎心音情形。
 - (4) 隨時觀察病患有無早產之跡象：如陰道出血、破水、宮縮。
 - (5) 若已破水，教導臀部抬高以減少羊水流出情形。
 - (6) 必要時請小兒科醫師說明，若發生早產新生兒加護單位會提供特殊照護，請其放心。

主題名稱	妊娠高血壓疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M12	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	4/9

(7) 若宮縮密集時，護理人員需提供有關新生兒的訊息如：胎心音給母親。

(8) 時常探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。

3. 易感染／早期破水

(1) 評估個案及家屬的認知。

(2) 治療前後洗手。

(3) 觀察羊水流出及陰道分泌物的量、色、味。

(4) 勤換產墊以保持乾燥避免感染，並觀察羊水流出情形。

(5) 每天會陰沖洗，保持會陰清潔，避免逆行性感染。

(6) 監測生命徵象及全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。

(7) 依醫囑給予抗生素治療。

(8) 每天為您裝胎兒監視器，監測胎心音及宮縮情形。

(9) 抽血或陰道培養做檢查。

(10) 教導選擇高蛋白、高熱量飲食，以提供胎兒生長所需之營養。

4. 缺乏營養／血色素低

(1) 配合個案食物喜好選擇高蛋白質、高熱量食物、含鐵及維生素 C 飲食幫助鐵質吸收。

(2) 進食前避免執行疼痛措施。

(3) 建議少量多餐以增加進食量。

(4) 建議清淡飲食，避免辛辣、刺激性食物。

(5) 教導孕期體重增加的範圍和熱量的控制須維持每日 2300-2500 卡。

(6) 監測所服用藥物、飲食改變及活動量。

(7) 衛教適當之飲食習慣，如：小口進食、細嚼慢嚥、可進食點心或選擇高纖維之點心並少量食用等。

(8) 當觀察到個案主動執行上述行為時，立即予以口頭讚賞以增強持續努力的動機。

(9) 監測生命徵象。

主題名稱	妊娠高血壓疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M12	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	5/9

5. 疼痛不適／與疾病引起子宮收縮有關

- (1) 評估孕婦的宮縮頻率及持續時間，並記錄。
- (2) 提供安胎相關訊息及衛教，包含胎兒監視及藥物作用副作用。
- (3) 與孕婦或家屬討論減少或排除疼痛的方法。
- (4) 協助孕婦改變姿勢以促進舒適。
- (5) 教導孕婦放鬆技巧，包括：腹部或背部按摩。
- (6) 轉移產婦注意力，包括：聽音樂、看電視、散步、閱書、聊天等。
- (7) 依醫囑給予藥物平滑肌鬆弛劑、消除腹部脹氣藥物。
- (8) 鼓勵家屬多陪伴，增加安全感。

6. 自我照顧尋求協助：如廁／依醫囑須絕對臥床休息

- (1) 監督個案如廁活動，並且視需要提供督導與協助，以確定其進展程度。
- (2) 當個案能獨立執行如廁活動時，給予支持與鼓勵。
- (3) 確認個案的排尿與排便型態，並協助建立排尿與排便計劃；當個案要求協助時立即回應，協助其達到控制與避免失禁發生。
- (4) 當個案如廁時，提供其隱密性。
- (5) 對個案失禁的現象不加以評論，以避免造成個案困窘及強忍如廁的需要。
- (6) 將呼叫鈴置於個案伸手可及之處。
- (7) 視需要協助個案清潔，重整衣物，確保乾淨舒適和整潔的外觀。

7. 心肺血流不足／高血容積

- (1) 評估水份攝入的量、種類以及排泄習慣。
- (2) 監測血壓、心跳及呼吸型態的變化。
- (3) 監測輸出入量。
- (4) 監測頸靜靜脈怒張、肺部濕囉音、周邊水腫及體重增加等情形。
- (5) 依醫囑維持適當的靜脈輸液速率。
- (6) 適當地限水及分配水份的攝取。
- (7) 適當地監測血清值及尿液中的電解質變化。

主題名稱	妊娠高血壓疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M12	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	6/9

(8) 適當地監測姿位性血壓及心臟節律的變化。

(六) 衛教指導

1. 務必絕對臥床休息，一切生活起居均在床上執行，包括：上大小號、吃飯、床上擦澡等，以預防子宮收縮加劇。
2. 每 2-4 小時依需要使用便盆解小便，請勿憋尿，因憋尿會引起子宮收縮。
3. 充分休息以減少子宮收縮刺激。
4. 勿食冰冷飲食避免造成子宮收縮。
5. 安胎藥物副作用會造成心跳及呼吸加快、面潮紅、發抖等，若感心悸、呼吸很喘或不適要告知護理人員。
6. 每週會安排超音波評估胎兒體重及成長情形。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 余玉眉、周雨樺、蕭仔伶、何美華、孫瑞瓊、林淑玲、黃樹欽、陳怡靜、徐莞雲(2020)．產科護理學（十版）．台北：新文京。
- (二) 李庭濤、周靜玉、何漢樺、曾英智(2021)．一位33週孕婦以突發性頭痛為表現，併發產後HELLP症候群．台灣專科護理師學刊，8(2)，68-76。
- (三) American College of Obstetrician and Gynecologists. (2019). Gestational hypertension and preeclampsia, *Obstetrics & Gynecology*, 133(1), 1–25.

主題名稱	妊娠高血壓疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M12	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	7/9

七、附件

(略)

主題名稱	妊娠高血壓疾病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-M12	版本	第 1.8 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.04.26	1.0	新制定	102 年 04 月 26 日護理部照護標準委員會通過；102 年 04 月 26 日公布
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	1.1	說明（四）護理問題及（五）護理措施新增內容：組織灌流改變：心肺／高血容積	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	1.2	增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	1.3	1.第三項說明內容將參考文獻出處呈現於內文中。 2.第六項文獻參考資料更新。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	1.4	增修第六項參考文獻資料	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.04.11	1.5	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 04 月 11 日照護標準組會議通過；108 年 05 月 15 日護理長會議通過；108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.18	1.6	1. 主題名稱中英文修訂：妊娠高血壓 Gestational Hypertension 改為妊娠高血壓疾病 Hypertensive disorders of pregnancy。 2. 第三項第一～三目說明內容修訂。 3. 第六項文獻參考資料更新。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

